

ICU勤務は子どもを持つ決断を変える — ESICM 32か国420人調査、非親の60%が影響を認め43%は育児支援ゼロ(調査・ICM2026)

出典	Scaramuzzo G, Jagodzinska-Peškova J, Grasselli G, on behalf of the ESICM Work-Family Balance, Parenting and Pregnancy group. Parenting, pregnancy and work-family balance in intensive care medicine: an ESICM survey and a call for action. Intensive Care Med. 2026;52(6):810-812. DOI: 10.1007/s00134-026-08365-x
掲載誌	Intensive Care Medicine (2026)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08365-x (本文PDFは別途)
原題	Parenting, pregnancy and work-family balance in intensive care medicine: an ESICM survey and a call for action



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

Hotel ICU の「医療者側」を測り、動かすための材料(試案) 本論文は欧州(イタリア57%)中心の認識調査であり、日本の数値ではない。したがって**結論をそのまま輸入せず、「問いの立て方」と「測り方」を借りるのが正しい使い方になる**。以下はその前提での試案。

■ 今日からコストゼロで始められること

- **「知らなかった」を潰す**: この調査で最も安く直せる項目は情報提供である。妊娠・出産・育児に関する制度(産前産後休業、育児休業、時短勤務、当直免除の申請経路、復職面談)を **1枚にまとめて配属時に配る**。本調査では妊娠中のパートナー側で「産休・育休の選択肢について明確な情報を得た」のは20%にとどまり、**集中治療に特化した勤務指針を受け取ったのは19%**だった。ここは制度を新設せずとも改善できる
- **妊娠報告を受けたときの初動を定型化する**: 報告→リスク評価(放射線、抗癌剤曝露、感染、夜勤、身体的負荷、暴力リスク)→勤務調整の相談→文書化、という4ステップを部門の手順として持つ。本調査では**制度上の健康・安全評価を受けたのは43%**にとどまっていた
- **パートナー側(父親側)を明示的に扱う**: 本調査では**父親の育休取得48%に対し母親88%、妊婦健診に付き添うための時間を取れたのは53%、勤務時間がパートナー支援の妨げになったと答えたのは72%**である。男性医師が多数を占める日本のICUでは、ここが最も伸びしろの大きい介入点になりうる

■ 部門ルールとして明文化するもの

- **当直・夜勤の負荷配分の透明化**: 本調査で親は勤務時間・夜勤・週末勤務が少なく、パートタイム比率が高かった。これは支援の結果でもあるが、裏返せば**その分の負荷がどこかへ移っている**ことを意味する。「誰かが黙って被る」構造を放置すると、支援そのものへの反発を生む。**移った負荷を可視化し、代償(回数上限・報酬・振替休)とセットで設計する**
- **キャリア penalty を切り離す**: 本調査では**46%が「親であることがキャリアの機会を狭めた」と回答**し、母親でその感覚が強かった(10点満点で母親7 対 父親等5)。時短・当直免除の期間中に、学会発表・研究・指導的役割から自動的に外れない運用(発表機会の割当、オンライン参加、共同研究での役割維持)を先に決めておく
- **復職プログラムの定型化**: 本調査では調整シフト・搾乳環境・構造化された復職プログラムの提供が「一貫していない」と報告された。復職1か月目の受け持ち軽減、夜勤再開時期の目安、搾乳スペースと時間の確保を**個別交渉ではなく既定の仕組みにする**

■ データで確かめること(自施設調査への展開)

- **同じ枠組みで自科を測る**: 本調査は WAFCS (Work-and-Family Conflict Scale、10項目・2下位尺度) という**既存の検証済み尺度**を使っている。同じ尺度を使えば自科の値を国際的な文脈に置ける。バーンアウト尺度と併せて年1回測ると、 **Hotel ICU・人間的ケア Home** の「医療者側」の指標として使える
- **測るなら医師だけにしない**: 本調査は看護師・関連職種を含む「ICU professionals」を対象にしている。聖路加でも**多職種で測る**ほうが実態に近い(負荷の非対称性は職種間でこそ大きい)
- **注意点**: 自施設調査でも本論文と同じ弱点(自己選択・低回答率・分母不明)を必ず抱える。**回答率を確保できる配布方法(部門会議での一斉回答など)**を先に設計しないと、「困っている人だけが答えた調査」になり、施策の説得力を失う

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: ICUは予測困難なシフトと重い認知的・情緒的負荷を特徴とする過酷な環境であり、**バーンアウトとモラル・ディストレス(道徳的苦悩)**はICUで既によく記述されている。また、ICU以外の診療科(外科医の調査など)では、**仕事と家庭の衝突がバーンアウトに有意に寄与することが示されていた**。
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: ICU従事者において、この過酷さが**家庭生活とどう相互作用するか**はほとんど検討されてこなかった。妊娠中の勤務、育児支援、親であることのキャリアへの影響について、ICUという設定に限定した情報は限られていた。
- **What's new(本研究の新規性・意義)**: ESICM の3部会(NEXT委員会、N&AHP委員会、Diversity & Inclusion Group)が合同で、**32か国420人のICU従事者**から回答を集め、**妊娠計画から妊娠中の就労、育児支援、キャリアへの影響までを家族形成の各段階にわたって記述した**。父親側・パートナー側の視点を含めた点、および検証済み尺度 WAFCS で**仕事→家庭／家庭→仕事**の方向性を分けて定量化した点が新しい。ただし著者ら自身が、**分母が定義できず回答率も算出できないオープンリンク方式の自己選択調査**であることを明記し、結果は「回答者における記述的な認識」であって母集団推定値ではない、サブグループ比較は探索的にすぎない、と繰り返し留保している。

全体要約

要旨

ひとことで ESICM が32か国420人のICU従事者に行った横断的オンライン調査。**子どもがいない回答者の60%が「ICU勤務が親になる決断に強く影響した」と答え**、既に子どもがいる人の46%が「もう1人持つ決断に強く影響した」と答えた。雇用主からの育児支援の主観的評価は10点満点で**中央値3、43%は支援を全く受けていない**。妊娠中も61%がICUで働き続けたが、集中治療に特化した勤務指針を受けたのは**19%**にとどまる。仕事→家庭の葛藤(中央値23)は家庭→仕事の葛藤(同15)より明確に高い。**ただし自己選択・分母不明の調査であり、著者らは母集団推定値ではないと明言している。**

内容	
問い	ICU従事者において、仕事と家庭の両立、および妊娠・育児への支援はどうなっているか
区分	Scientific Letter(*Intensive Care Med* 2026)。 横断的オンライン調査 。RCTでも前向きコホートでもない
主体	ESICM NEXT委員会・N&AHP委員会・Diversity & Inclusion Group の合同
期間・規模	2025年3月～9月／ 420人・32か国 。欧州93%(イタリア57%、オランダ16%、英国6%)
回答者像	女性62%、平均年齢 40 ± 9歳 、平均ICU経験 11 ± 9年 、コンサルタント40%・シニアレジデント24%、 親である人が67%(子の数は中央値2人)
家族形成への影響	非親の 60% が「親になる決断に強い／非常に強い影響」。有子者の 46% が「もう1人持つ決断に強い／非常に強い影響」(女性50% 対 男性40%、ジュニアレジデント70%)
育児支援	雇用主の支援の主観評価は10点満点で 中央値3(IQR 1-5) 。内容は柔軟性27%・ローテーション調整20%・勤務時間短縮17%。 43%は支援なし、60%が「雇用主は親であることを十分に支援していない」
育休取得	母親88% 対 父親48% (性差の可能性)
妊娠中の就労	妊娠セクション回答192人中、 61%が妊娠中もICU勤務を継続 。国のガイドラインを知っていたのは76%だが、 集中治療に特化した指針を受けたのは19%、制度上の健康・安全評価を受けたのは43% 。妊娠中の雇用主支援の主観評価は 中央値4(IQR 2-6)
パートナー側	妊婦健診に付き添う時間を取れた53%、職場が予定親としての役割に支持的だと感じた45%、 勤務時間がパートナー支援を妨げた72% 、産休・育休の選択肢について明確な情報を得た 20%
仕事-家庭の葛藤	WAFCS で 仕事→家庭 23(IQR 20-27) 対 家庭→仕事 15(IQR 10-19) 。女性で仕事→家庭の葛藤が高い
キャリアへの影響	46%が「親であることがキャリアの機会を狭めた」 に同意／強く同意。10点満点で 母親7(IQR 4-8) 対 5(IQR 2-8)
限界	自己申告データ、選択バイアスの可能性、一般化可能性の制限。 オープンリンク方式のため適格者の分母が定義できず、回答率を信頼できる形で算出できない 。地理的偏り、育児政策の多様性、性別の

内容

偏り、自発的自己選択デザインが代表性を損なう。結果は記述的な認識であって母集団推定値ではなく、サブグループ比較は探索的

押さえるべき6点

- 1 これは「困っている人がどれだけいるか」の推定ではない。オープンリンクの自己選択調査であり、著者ら自身が母集団推定値として読むなという留保を明示している。議論すべきは数値の外的妥当性ではなく、示された論点の存在そのもの
- 2 影響は「子どもを持つ前」から始まっている。非親の60%が親になる決断への強い影響を認め、ジュニアレジデントでは70%に達する。キャリア初期の負荷設計が家族形成の意思決定を左右しているという構図
- 3 支援の欠如は「量」より「不在と不明確さ」の問題。43%が支援ゼロ、集中治療特化の妊娠中指針は19%、産休・育休情報の明確な提供は20%。制度の新設より情報提供と定型化のほうが先に効く余地が大きい
- 4 葛藤の方向は圧倒的に仕事→家庭(23 対 15)。家庭が仕事を妨げているのではなく、仕事が生計を侵食している。したがって介入すべき対象は個人のレジリエンスではなく勤務の設計
- 5 性差が一貫して現れる：育休取得(88% 対 48%)、キャリア制約の認識(母親7 対 5)、仕事→家庭の葛藤(女性で高値)。ただし回答者の62%が女性という偏りがあり、著者らも性別の偏りを限界として挙げている
- 6 父親・パートナー側の数値が同時に示されているのがこの調査の特徴。72%が勤務時間のせいでパートナーを支えられなかったと答えている

詳細

1. まず前提 — なぜICUで「仕事と家庭の両立」が問題になるのか

要旨

5分で背景を掴む ICUという職場は、**シフトが予測しづらく (unpredictable shifts)**、**認知的・情緒的な負荷が重い (heavy cognitive and emotional loads)**という2つの特徴を持つ。夜勤・週末勤務が構造的に避けられず、患者の急変や死をめぐる意思決定が日常的に発生する。

この環境が医療者に与える影響として、これまで主に2つが記述されてきた。ひとつは **バーンアウト (燃え尽き症候群)** = 情緒的消耗・脱人格化・個人的達成感の低下を特徴とする状態。もうひとつは **モラル・ディストレス (moral distress / 道徳的苦悩)** = 「正しいと分かっていること」が組織や制度の制約でできないときに生じる苦痛である。どちらもICUでよく研究されてきた。

ところが、これらが**家庭生活とどう相互作用するか**はあまり調べられてこなかった。ICU以外の診療科（たとえば米国外科医の大規模調査）では、**仕事と家庭の衝突 (work-home conflict)**が**バーンアウトに有意に寄与する**ことが示されている。にもかかわらず、ICU従事者ではこの点の情報が乏しい。本調査はこの空白を埋めるために企画された。

仕事-家庭の葛藤には方向がある、というのがこの分野の基本概念である。本調査が使った **WAFCS (Work-and-Family Conflict Scale)** は、10項目・2下位尺度で構成される検証済みの自己記入式尺度で、

- **仕事→家庭の葛藤 (Work-to-Family Conflict、項目1-5)** = 仕事が家庭生活を妨げる方向
- **家庭→仕事の葛藤 (Family-to-Work Conflict、項目6-10)** = 家庭の責任が仕事を妨げる方向

を分けて測る。どちらが優勢かによって、打つべき手（勤務設計を変えるのか、家庭側の支援を厚くするのか）が変わるため、この方向性の区別は実務上重要である。

なお、本論文は原著論文ではなく **Scientific Letter (3ページの短報)** である。方法の詳細と大半の表 (Table S1-S9) は Online Supplement に置かれており、本文で読めるのは要点だけである点を最初に押さえておく。

2. 調査の目的と実施主体

著者らは冒頭で問題設定を次のように述べている。ICUは過酷な環境であり、バーンアウトとモラル・ディストレスは既によく記述されているが、**それらが家庭生活とどう相互作用するかはあまり検討されてこなかった**。他の診療科では仕事-家庭の衝突がバーンアウトに寄与することが示されているのに対し、**ICU従事者では限られた情報しかない**。

このギャップを埋めるため、以下の3部会が合同で調査を立ち上げた。

実施主体	位置づけ
ESICM NEXT Committee	若手集中治療医 (Next Generation) を対象とする部会
ESICM N&AHP Committee	看護師・関連医療専門職 (Nurses and Allied Health Professionals) の部会
ESICM Diversity & Inclusion Group	多様性と包摂を扱うグループ

調査の目的は、ICU従事者における「仕事と家庭のバランス」および「親になること・妊娠に対する支援」を探索し記述すること (explore and describe) と明記されている。仮説検証型の研究ではなく、記述的調査として設計されている点は、結果の読み方を決めるうえで重要である。

3. 方法(Methods)

本文はScientific Letterのため方法の記載が極めて簡潔であり、「開発・配布・解析の詳細は Online Supplement に報告した」とのみ書かれている。本文から読み取れる範囲を整理する。

項目	内容
デザイン	横断的 (cross-sectional) オンライン質問紙調査
調査期間	2025年3月～9月 (約7か月)
対象	ICU professionals (医師に限らず、看護師・関連医療専門職を含む)
回答数	420人・32か国
配布方法	オープンにアクセス可能な調査リンク (本文の限界の項に「the survey link was openly accessible」と明記)
回答率	算出不能。適格なICU従事者の分母を正確に定義できなかったため、著者らは「回答率を信頼できる形で算出できなかった」と明記している
質問紙の構成	少なくとも「回答者背景」「家族形成の決断への影響」「育児・親であることへの支援」「妊娠中の就労と支援」「パートナー (予定親) 側の経験」「仕事-家庭の葛藤 (WAFCS)」のセクションを含む。妊娠セクションは192人が回答 (全420人のうち該当者のみが回答する構造)
主要な測定尺度	WAFCS (10項目・2下位尺度: 仕事→家庭 項目1-5、家庭→仕事 項目6-10)。加えて、雇用主の支援については10点満点のスケールで主観評価を求めている
解析	記述統計 (割合・平均±標準偏差・中央値[IQR]) が中心。親／非親、女性／男性、職位などのサブグループ比較が示されるが、著者らはこれを探索的 (exploratory only) と位置づけている。本文中に検定のp値は示されていない
補足資料	Table S1-S9、Fig. S1・S2・S5 に、回答者背景、親／非親の比較、勤務実態、育休、妊娠中の支援、産後の支援、各国の育児政策の多様性などが収載されている

△ 注意

方法上の最大の制約 **分母が定義できない調査であるため、本文中の割合はすべて「回答した420人の中での割合」であり、ICU従事者一般の有病率・頻度ではない。** 著者ら自身が「findings should be interpreted as descriptive perceptions among respondents rather than population-level estimates」と明記している。ジャーナルクラブでこの点を外すと、数値を過大に引用する誤りが起きる。

4. 回答者の背景 (Survey population) 👤

地理的分布

地域・国	割合
欧州全体	93%
イタリア	57%
オランダ	16%
英国	6%
その他 (32か国)	残り

回答者像

項目	値
女性	62%
平均年齢	40 ± 9歳
平均ICU経験年数	11 ± 9年
コンサルタント (指導医相当)	40%
シニアレジデント	24%
親である人	67% (子の数は中央値2人)

親であることと関連した特徴 (Table S3)

親である回答者は、非親と比べて次の特徴を持っていた。

- 年齢が高い
- ICU経験年数が長い
- より安定した雇用契約 (stable contracts)
- より上位の役職 (senior roles)

親の勤務実態 (Table S4)

- 週あたりの勤務時間が少ない
- 夜勤が少ない
- 週末勤務が少ない
- パートタイム勤務の割合が高い

この2つの表は、親であることが「支援を受けた勤務」と結びついていることを示すと同時に、親であること自体が年齢・経験・地位と交絡していることも示している。つまり「親は夜勤が少ない」という所見は、支援の結果かもしれないし、単に年次が上がって夜勤から外れているだけかもしれない。横断デザインではこの2つを区別できない。

5. ICU勤務が家族形成の選択に与える影響 🧐

本調査でおそらく最もインパクトのある結果がここである。

対象	質問	結果
子どもがいない回答者	ICUで働くことが「親になるという決断」に影響したか	60%が「強い／非常に強い影響があった」
子どもがいる回答者	ICUで働くことが「もう1人子どもを持つという決断」に影響したか	46%が「強く／非常に強く影響した」
└ 女性	同上	50%
└ 男性	同上	40%
└ ジュニアレジデント	同上	70%

読み取るべき点は3つある。

- 1 影響は「子どもを持ってから」ではなく「持つ前」から始まっている。非親の60%という数字は、ICU勤務が家族形成そのものの意思決定に届いていることを意味する
- 2 女性で高い(50% 対 40%)が、男性でも40%と決して低くない。これは「女性の問題」ではなく職場設計の問題であることを示唆する
- 3 ジュニアレジデントで70%と最も高い。キャリア初期＝夜勤・週末勤務の負荷が最も重く、雇用が最も不安定で、かつ生物学的に家族形成の時期と重なる層に、影響が集中している

著者らは考察で、この所見が「高度に要求の厳しい環境が出産・育児に及ぼす負の帰結を裏づけるもの」であり、麻酔科医・集中治療医3590人を対象とした最近の欧州調査(Zdravkovic ら、Br J Anaesth 2024)と同様の方向であると述べている。

6. 育児・親であることへの支援 (Support for childcare and parenthood) 🍼

雇用主からの育児支援の主観的評価

- 10点満点のスケールで 中央値3 (IQR 1–5) = 低い
- IQR の下限が1であることから、「ほとんど支援がない」と感じている層が四分の一以上いる

支援がある場合の内容 (複数回答と思われる)

支援の種類	割合
柔軟性 (flexibility)	27%
ローテーションの調整 (facilitated rotations)	20%
勤務時間の短縮 (reduced working hours)	17%

支援がない層

- 43%が「支援を一切受けていない」と回答
- 60%が「雇用主は親であることを適切に支援している」に同意しなかった

育児休業の取得 (Table S5)

対象	取得率
母親	88%
父親	48%

著者らはこれを「性差の可能性 (possible gender differences)」と慎重な表現で記述しており、断定していない。この表現の慎重さは、調査デザイン上、各国の制度差 (父親の育休制度の有無・給付水準) を統制していないことを反映していると読める。実際、限界の項では各国の育児政策の多様性 (Table S9) が代表性を損なう要因として挙げられている。

7. 妊娠中のICU勤務と支援(Support during pregnancy) 🧑🏻

妊娠セクションに回答したのは **192人**(全420人の一部)である。

項目	結果
妊娠中もICUで勤務を継続した	61%
国の妊娠中就労ガイドラインを知っていた	76%
集中治療に特化した指針を受け取った	19%
制度上の健康・安全評価(institutional health and safety assessments)を受けた	43%
妊娠中の雇用主支援の主観評価(10点満点)	中央値4 (IQR 2–6)

この4つの数字の並びが、この調査で最も鋭い指摘である。**国レベルのガイドラインの認知(76%)と、集中治療という具体的な現場に落とし込まれた指針(19%)の間に、およそ4倍の落差がある。**ICUには放射線、細胞毒性薬剤、感染性病原体、身体的負荷、暴力リスクといった妊娠中に固有の配慮を要する曝露が存在するにもかかわらず、それを扱う具体的指針が現場に届いていない。

産後の支援 (Table S7)

- 調整されたシフト (adjusted shifts)
- 授乳・搾乳のための設備 (breastfeeding facilities)
- 構造化された復職プログラム (structured return-to-work programs)

これらは「**一貫性なく提供されていた (inconsistently provided)**」と記述されている。著者らは割合を本文に示さず、この表現にとどめている。**あるところにはあり、ないところにはない**という状態である。

妊娠中のパートナー側(予定親)の経験

項目	結果
妊婦健診に付き添うために職場を離れる時間を取れた	53%
職場が「予定親としての自分の役割」に支持的だと感じた	45%
勤務時間がパートナーを支える能力を妨げた	72%
産休・育休の選択肢について明確な情報を得た	20%

72%と20%という2つの数字が対照的である。大多数が勤務のせいでパートナーを支えられないと感じている一方で、制度情報が明確に伝わっているのは5人に1人にすぎない。情報提供は制度の新設を伴わずに改善できる領域であり、実務上の優先度が高い。

8. 仕事と家庭の葛藤 — WAFCS の結果 (Fig. 1)

図の解説

Figure 1 — Work and Family Conflict Scale(WAFCS)の項目別回答分布 **原題**:Results from the Work and Family conflict scale. **和訳(要旨)**:ICUスタッフの親における WAFCS の結果。**仕事→家庭の葛藤のほうが、家庭→仕事の葛藤より高い**ことを示す。回答は**親に限定(n = 274)**。尺度は2つの5項目下位尺度からなり、**仕事→家庭の葛藤(項目1-5)**は仕事が家庭生活を阻害する方向、**家庭→仕事の葛藤(項目6-10)**は家庭の責任が仕事に干渉する方向を表す。

図の見た目:横向き**の発散型100%積み上げ棒グラフ(diverging stacked bar chart)**。縦軸に10項目の設問文が上から順に並び、横軸は Percentage(中央の0を境に、左へ100%、右へ100%)。中央には0の位置を示す破線が縦に引かれている。

色の割り当て(凡例は図の下に2行で配置):

- 左方向(否定側) = **マゼンタ～紫系**。濃いマゼンタが「Very strongly disagree(非常に強く不同意)」、やや濃いマゼンタが「Strongly disagree(強く不同意)」、淡いピンクが「Disagree(不同意)」
- 中央 = **ごく淡い灰白色**の「Neither agree nor disagree(どちらでもない)」
- 右方向(肯定側) = **水色～青系**。淡い水色が「Agree(同意)」、中間の青が「Strongly agree(強く同意)」、濃い青が「Very strongly agree(非常に強く同意)」

数値ラベル:各行の左端に「不同意側の合計%」、中央に「どちらでもない%」、右端に「同意側の合計%」が数字で付されている。

上5項目が仕事→家庭、下5項目が家庭→仕事という並びになっており、**上半分では棒が右(同意=葛藤あり)に大きく伸び、下半分では左(不同意=葛藤なし)に大きく伸びる**という、視覚的に一目で分かる非対称が現れている。

図から読み取れる項目別の内訳(左=不同意計／中央=どちらでもない／右=同意計)

#	設問(要旨)	不同意	どちらでもない	同意
01	仕事のせいで家族と十分な質の時間を過ごせない	26%	16%	58%
02	一日の終わりに、家でやりたいこと(家事や余暇)をする時間が残っていない	22%	12%	66%
03	仕事の責務のせいで家族が損をしている	18%	15%	68%
04	仕事が家庭生活に負の影響を与えている	31%	22%	46%
05	働くことで、家で苛立ちやすく気が短くなる	32%	15%	53%
06	個人的・家庭的な責務のせいで仕事のパフォーマンスが落ちる	51%	19%	30%
07	家庭関連の心配ごとや責任が、職場でしばしば気を散らす	58%	18%	24%
08	家族がいなければ、自分はもっと良い従業員でいられる	61%	16%	23%
09	家族が日々の業務に負の影響を与えている	74%	12%	14%
10	家庭の責任で疲れ切っていて、職場で集中するのが難しい	68%	15%	16%

下位尺度スコアの比較(本文記載)

下位尺度	中央値 [IQR]
仕事→家庭の葛藤	23 [20-27]
家庭→仕事の葛藤	15 [10-19]

さらに、女性のほうが仕事→家庭の葛藤のスコアが高い(Figure S5)。

この図の読み方として最も重要なのは、葛藤が一方向に偏っているという点である。項目03では68%が「仕事の責務のせいで家族が損をしている」に同意する一方、項目09では74%が「家族が日々の業務に負の影響を与えている」を否定している。つまりICU従事者は、家庭が仕事の足を引っ張っているとは考えておらず、仕事が家庭を侵食していると認識している。介入の対象が個人の家庭管理能力ではなく勤務そのものの設計にあることを、データが方向づけている。

9. 親であることとキャリア

- 46%が「親であることが自分のキャリアの機会を狭めた」に同意／強く同意
- 10点満点の評価では 母親 7 (IQR 4–8) 対 5 (IQR 2–8)

著者らは考察で、「親であることは仕事上の機会に対する障害として一般的に認識されており、これは十分に調査されていない構造的障壁(structural barriers)を反映している」と述べている。ここでも「構造的」という言葉が選ばれており、個人の選択の問題ではなく組織側の設計の問題として枠づけられている。

10. 著者らの考察と限界(Impact and limitations)

著者らが述べた所見の意味

- ICUで働くことは、妊娠計画から育児まで、家族生活の各段階にわたって親であることの決断と経験に影響している
- 母親側からも父親側からも影響が観察された
- 公平性とワークライフバランスへの関心が高まっているにもかかわらず、ICUにおける妊娠と育児への支援は依然として限定的・一貫性を欠き・しばしば不明確 (limited, inconsistent, and often unclear) である
- 多くの専門職が、ICU特有の指針や構造化された職業上の保護がほとんどないまま、高リスク環境で妊娠中も働き続けている

著者らが明示した限界

限界	内容
自己申告データ	すべて回答者の主観に基づく (self-reported data)
選択バイアスの可能性	potential selection bias
一般化可能性の制限	restricted generalizability
分母が定義できない	調査リンクがオープンにアクセス可能だったため、適格なICU従事者の正確な分母を定義できず、回答率を信頼できる形で算出できなかった
地理的偏り	欧州93%、イタリア57%に集中
育児政策の多様性	各国で制度が大きく異なる (Table S9)
性別の偏り	回答者の62%が女性
自発的自己選択デザイン	voluntary self-selection design

著者らの結論的な留保 (原文の慎重さのまま)

- 結果は「回答者における記述的な認識 (descriptive perceptions among respondents)」として解釈すべきであり、母集団レベルの推定値ではない
- サブグループ比較は「探索的にすぎない (exploratory only)」

そのうえで著者らは、「それでもなお (Nevertheless)、これらの結果は、妊娠および育児に伴う職業上の不利益 (professional penalties) の可能性を減らすために、より明確で共有された制度的方針、労働条件、能動的な組織的支援を支持するものである」と述べている。

11. 今後の方向性 (The way forward) 🧭

著者らが示した「行動提起 (call for action)」の中身は、実は具体的な施策リストではなく、研究上の要請である。

- 育児の責任とICUの業務量を両立させることは、回答者の間でしばしば困難と報告された
- これらの所見は、集中治療における妊娠と育児が、とくに組織的方针と職場支援の観点から、さらに構造化された調査に値することを示唆する

- 代表性のあるデザイン(representative designs)を用いた今後の研究が、問題の広がりを理解し、エビデンスに基づいた制度的戦略を提供するために必要である

つまり本論文は、「何をすべきか」を示した論文ではなく、「ここに測られていない問題がある」と旗を立てた論文である。ジャーナルクラブでは、この位置づけを取り違えないことが重要になる。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

調査研究としての構造的限界(ここが最大の論点) ① 分母が存在しない = 回答率が計算できない オープンリンク方式のため、420人という数字が「何人中の420人」なのかが分からない。ESICM会員数を分母と仮定しても、リンクは会員外にも開かれていた。したがって「60%が影響を受けた」は「ICU従事者の60%」ではなく「答えた人の60%」である。

② 自己選択バイアスの方向は「過大評価」側にほぼ確実に働く「仕事と家庭の両立」というテーマの調査に自発的に回答するのは、その問題に関心が高い人、あるいは実際に困っている人である。満足している人が回答する動機は乏しいため、報告された困難の割合は真の値より高く出ている可能性が高い。この方向の偏りは、施策の必要性を訴える文脈では特に注意して扱う必要がある。

③ 横断デザインでは因果の向きを決められない「親は夜勤が少ない」は、支援の結果とも、年齢・地位の交絡とも読める(実際、親は年齢が高く経験年数が長く上位職だった)。同様に「ICU勤務が子どもを持つ決断に影響した」は回答時点での回想的な自己帰属であり、実際の出生行動を追跡した結果ではない。

④ サンプルの偏りが結論の適用範囲を強く制限する

- イタリア1国で57%。ESICMの調査でありながら、実質的には「イタリアの状況+その他」に近い構成になっている
- 欧州93%であり、アジア・北米・アフリカ・南米の実態はほぼ反映されていない
- 女性62%は、多くの国のICU医師の性別構成より女性に偏っている可能性がある。性差を論じる際、この偏りが方向にどう作用するかは評価できない
- 職種構成も「コンサルタント40%・シニアレジデント24%」までしか本文に示されず、看護師・関連職種が何%を占めるかが本文からは読めない。N&AHP委員会が共催しているにもかかわらず、職種別の分解が本文にない点は物足りない

⑤ 検定・効果量の提示がない

本文中のサブグループ比較(女性50% 対 男性40%、母親88% 対 父親48%、母親7 対 5)に**p値も信頼区間も示されていない**。著者ら自身が「探索的」と断っているため誠実ではあるが、**ジャーナルクラブで「有意差がある」と述べてはいけない**。差の大きさの解釈は、n数(とくに妊娠セクションは192人、WAFCSは274人)とサブグループの人数が本文に示されていないことも踏まえて慎重に行う必要がある。

⑥ Scientific Letter という形式そのものの制約

3ページという枠のため、方法の記載が「Online Supplement を参照」の一行に圧縮されている。**質問紙の項目文、妥当性検証の有無、配布チャネル、重複回答の防止策、欠測の扱いが本文からは一切分らない**。調査研究の質評価に用いられる CHERRIES(インターネット調査の報告ガイドライン)の観点からは、本文だけでは評価不能である。批判的吟味を厳密に行うなら Supplement を取り寄せる必要がある。

⑦ 「行動提起(call for action)」の中身が研究要請にとどまる

タイトルに call for action と掲げているが、本文で提案されているのは「**代表性のあるデザインによる今後の研究**」であり、**具体的な施策パッケージや推奨は示されていない**。組織として何を導入すべきかの答えは、この論文からは得られない。**ただしこれは欠点というより、エビデンスが薄い段階で推奨を出さなかった誠実さとも読める**。

聖路加ICUでの実践

それでもこの論文が価値を持つ理由

- **測られてこなかった領域に、検証済み尺度(WAFCS)で数字を入れた**。方向性(仕事→家庭が優勢)という所見は、バイアスの影響を受けにくい**相対比較**であり、絶対値より信頼できる
- **父親・パートナー側を同じ調査に含めた**。「両立支援＝女性の問題」という枠組みを外している
- **「国のガイドライン認知76% 対 ICU特化指針19%」という落差は、選択バイアスがあっても説明しにくい大きさであり、制度と現場の断絶を示す所見として説得力がある**
- **限界の記述が具体的で誠実**。分母が定義できないこと、結果を母集団推定値と読んではいけないこと、サブグループ比較が探索的であることを、自ら明記している

日本の集中治療の文脈に置き換えて考える

本調査は日本のデータを含まない(欧州93%)。それでも、日本のICUに引きつけると次の論点が浮かぶ。**以下は本論文の所見からの推論であり、論文が示した事実ではない**。

論文の所見	日本の文脈で考えるべきこと
ジュニアレジデントの70%が「もう1人持つ決断に強い影響」	日本の専門医制度は研修・症例要件が年次に紐づき、 中断・時短がそのまま取得時期の遅れに直結 しやすい。制度側の柔軟性（症例数の按分、期間の延長規定）が両立可能性を左右する
父親の育休取得48%（欧州）	日本の男性医師の育休取得率はこれより低い水準にあると考えられる。 取得率そのものより「取れる前提になっているか」 が職場文化の指標になる
妊娠中も61%がICU勤務継続、ICU特化指針は19%	日本でも当直・夜勤の免除基準や曝露管理は 施設ごとの個別対応 になりがち。学会レベルの指針があれば個別交渉の負担が減る
仕事→家庭の葛藤が優勢	当直明けの勤務、宿日直許可の扱い、時間外労働の上限規制（医師の働き方改革）と直結する論点。 制度改正が家庭側の指標を改善したかは、まだ測られていない
親は夜勤・週末勤務が少ない	負荷の移転先が明示されないまま支援を進めると、 支援を受けない層の不満 が生じる。日本の当直体制は少人数で回すため、この問題がより先鋭化しやすい

主要な引用文献（本文で言及された研究）

本Letterが引用しているのは**5文献のみ**である。短報のため引用は絞られているが、いずれも議論の骨格を成しており、ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高い。

内容	研究
ICUスタッフのバーンアウトを減らすポジティブ・コミュニケーション(クラスターランダム化試験)	Azoulay É, Myatra SN, Heras La Calle G ら、 *Intensive Care Med*, 2025年、51:2031–2041
スペインのICU従事者におけるモラル・ディストレス	Rodriguez-Ruiz E, Campelo-Izquierdo M, Veiras PB ら、*Med Intensiva*, 2022年、46:383–391
仕事–家庭の衝突とバーンアウトの関係(米国外科医・性別比較)	Dyrbye LN, Shanafelt TD, Balch CM ら、*Arch Surg*, 2011年、146:211–217
WAFCS の開発と初期妥当性検証(本調査が使用した尺度の出典)	Haslam D, Filus A, Morawska A ら、*Child Psychiatry Hum Dev*, 2015年、46:346–357
妊娠中の労働条件: 欧州の麻酔科医・集中治療医 3590人の調査(本調査が「同様の方向」と述べた先行調査)	Zdravkovic M, Kabon B, Dow O ら、*Br J Anaesth*, 2024年、133:1062–1072

とくに **Zdravkovic ら 2024(n = 3590)** は、本調査(n = 420)の約8.5倍の規模で妊娠中の労働条件を扱っており、**本調査の所見を大規模データで確認するための第一の参照先**になる。ジャーナルクラブで「この所見はどこまで再現されているか」を問うなら、まずこの論文を並べて読むのがよい。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ESICM の32か国420人調査は、**ICU勤務が「子どもを持つかどうか」という決断そのものに届いていることを示した**(非親の60%、ジュニアレジデントでは70%)。育児支援の主観評価は10点満点で中央値3、43%は支援ゼロ、妊娠中に集中治療特化の指針を受けたのは19%にとどまる。葛藤の方向は明確に**仕事→家庭**(23 対 15)であり、直すべきは個人の頑張り方ではなく勤務の設計である。

ただしこれは分母の定義できない自己選択調査であり、著者ら自身が「母集団推定値ではなく回答者の記述的な認識」と明記している。数値を日本や自施設の実態として引用してはいけない。この論文から借りるべきは数値ではなく、WAFCS という測り方と、「情報提供の欠如は制度を新設せずに直せる」という着眼点である。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。